EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 86454
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-06-11 14:57:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MIRTA CELSA SALAZAR RIQUELME			**RUN**	: 10.360.603-9
F.Nac	: 09-08-1963	**Edad**	: 60 AÑOS, 10 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: MAÑIO 869 PB.11 SEPT			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 973915434		
Fecha Ingreso	: 2024-06-02	**Fecha Egreso**	: 2024-06-11 14:57:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. E14-DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Lesión renal renal aguda KDIGO3/ERC etapa 3a
- Acidosis metabólica 2° resuelta
2. Sepsis foco urinario
3. Sdme. hiperglicémico No cetósico no hiperosmolar
4. Bronquiolitis bilateral
5. Antecedentes: Hipotiroidismo, cardiopatía coronaria (CRM), amputación 3° ortejo pie izquierdo, DM2

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec. DM2, ITU a repetición. Desde hace 1 sem aprox, previo al ingreso, con tos productiva. Fue evaluada en su CESFAM el 29/05, le diagnostican NAC e indican azitromicina. Evolución tórpida, refiere que desde el 30.05 con disuria y oliguria, mayor compromiso del estado general. Por lo que tras ser evaluada nuevamente en su CESFAM es derivada a SU HSC por sospecha de ITU. Ingresa al SU hemodinámicamente estable. sat 99% amb. Se tomaron HC y se inició ceftriaxona. Destacan exámenes de laboratorio con falla renal con acidosis metabólica y leve aumento de parámetros inflamatorios. Lab: crea 6,8 Uremia 209 lactato 0.8 Glic 498 GSV pH 7,16 pCO2 28 pO2 36 Bic 10 PCR 33,8 GB 16500 OC infecciosa cuerpos cetónicos (-).
Se rescata PieloTAC sin evidencia de urolitiasis y TAC de tórax sin imágenes nodulares ni signos de condensación, sin signos de derrame pleural
TAC TAP donde se evidencia signos de bronquiolitis bilateral, leve derrame pleural bilateral, fractura por aplastamiento T11, signos de barro biliar-microlitiasis vesicular
Por clínica respiratoria se solicitó panel viral (+) VRS
Además se rescata UC (+) E. Coli MS por lo que se mantiene tto ATB con ceftriaxona con buena respuesta clínica y de laboratorio, hemocultivos negativos; cursó con peak febril el 07.06 pero sin repercusión clínica ni hemodinámica, con conducta expectante y sin nuevos episodios febriles.
Desde el punto de vista renal, se inicio aporte con bicarbonato asociado a hidratación por prerrenalidad con respuesta adecuada y se reinician antihipertensivos. Acidosis resuelta, sin criterios de HD de urgencia, creatinina en regresión lenta, actualmente en 3,6 en descenso, con diuresis conservada.
Hoy se toma ex de orina y urocultivo porque se observa orina aún blanquecina, pero parámetros a la baja por lo que se decide continuar seguimiento en hodom hasta tener urocultivo.

PLAN DE MANEJO:

Control de exámenes en 48hrs
Rescatar urocultivo tomado hoy 11/06

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Regimen bajo en azucar
3. Hidratación de al menos 2 lts al día
4. Ceftriaxona 2gr ev 9/12
5. Ciprofloxacino 500mg 1 c 12hrs por 7 días vo
6. Paracetamol 1 gr sos dolor vo
7. Omeprazol 20mg vo
8. Amlodipino 10mg vo
9. Aspirina 100mg vo
10. Atorvastatina 40mg 1 c noche vo
11. Metformina 850mg 1 comp antes del almuerzo
12. Insulina NPH 10 u am SC

PANIQUE PEDRAZA MARIANA ANDREA
MEDICO TRATANTE
24689611-9

JEFE SERVICIO